

地域で支える緩和ケア ― 私たちにできること

対象：全スタッフ（看護師・介護士・事務職員・リハビリ職等）

所要時間：20 分

ID モデル：ガニエの 9 教授事象

作成日：2026-03-26

スライド 1: タイトル

所要時間 : 20 分

今日のルール : 正解を求めません。感じたことを大切にしてください。

スライド 2: 問いかけ（注意の喚起）

「この方、最近つらそうだな」
「もう少し何かできることがあるんじゃないかな」

と感じたことはありませんか？

→ その「気づき」こそが、緩和ケアの出発点です。

☒ ガニエ第 1 事象：学習者の注意を喚起する

スライド 3: 今日のゴール（学習目標の提示）

- 緩和ケアは「終末期だけのもの」ではないとわかる
- あなたの職種でできる緩和ケアが1つ見つかる
- 困ったときに誰に相談すればいいかがわかる

「自分には関係ない」→「自分にもできることがある」
この変化が今日のゴールです。

☒ ガニエ第2事象：学習目標を知らせる

スライド 4: まず、誤解を解きましょう（前提条件の想起）

よくある誤解:

誤解	実際
---	---
終末期の人だけが受けるもの	診断されたときから始められる
がんの人だけが対象	心不全、認知症、呼吸器疾患なども対象
特別な専門家だけがやること	すべての職種が関われる
「もう何もできない」ということ	「できることはまだたくさんある」ということ

☒ ガニエ第3事象：前提条件を思い出させる

スライド 5: WHO の定義をやさしく

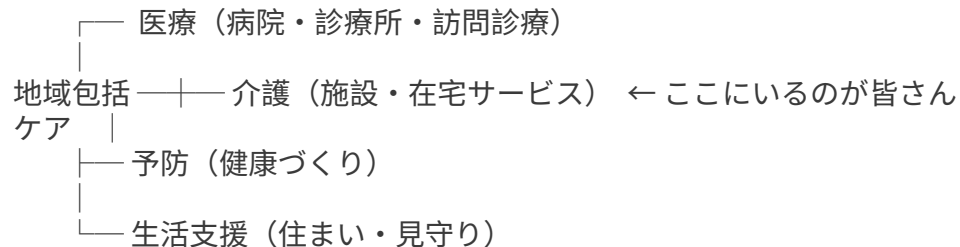
重い病気に向き合う患者さんご家族の
「つらさ」を和らげて
その人らしい生活を支えること

「つらさ」には 4 つの種類があります：

体のつらさ		痛み、息苦しさ、だるさ
心のつらさ		不安、悲しみ、怒り
人とのつながりのつらさ		孤独、家族との関係
生きる意味のつらさ		「何のために生きているのか」

体のつらさだけが緩和ケアではありません。

スライド 6: 地域包括ケアの中の緩和ケア

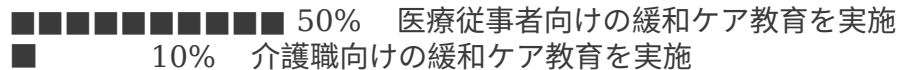


緩和ケアは、このすべてに横串を通すもの。

利用者さんの「つらさ」は、医療の場だけでなく、介護の場、生活の場で日々感じられている。

スライド 7: 衝撃のデータ

日本緩和医療学会の全国調査（528 施設）によると ...



** 介護職は、利用者さんと最も長い時間を過ごしているのに、

緩和ケアについて学ぶ機会が最も少ない。 **

1 日の接触時間（施設の場合）

介護職：8-16 時間

看護師：1-2 時間

医師：数分 - 数十分

→ 一番近くにいるあなたの「気づき」が、一番大切。

☒ ガニエ第 4 事象：新しい内容を提示する（データで実感を促す）

スライド 8: あなたの職種でできること

職種	あなたにできる緩和ケア
---	---
介護士	日常の変化に気づく。「いつもと違う」を伝える。声かけ、傾聴、安楽な姿勢の工夫
看護師	症状の評価、医師への報告、ケアプランへの反映、介護職の相談窓口
リハビリ職	「できること」を維持する支援、動作時の痛みの評価、リラクゼーション
事務職員	家族への丁寧な対応、環境整備、情報連携のサポート
栄養士	食べたいものを聞く、食べやすい形態の工夫、栄養より「楽しみ」
相談員	家族の不安への寄り添い、社会資源の紹介、意思決定の支援

「自分の仕事の延長線上」に緩和ケアはあります。

☒ ガニエ第 5 事象：学習の指針を与える

スライド 9: 具体的な場面で考えてみましょう

いつもの「おはようございます、よく眠れましたか？」

これだけで立派な緩和ケアのアセスメントです。

+ ひと言の例:

- 「体のどこか痛いところはありませんか？」
- 「何か気になっていることはありますか？」
- 「昨日のお薬は楽になりましたか？」

食事量が減ってきた利用者さんに:

- ☒ 「ちゃんと食べないと元気になれませんよ」
- ☒ 「食べたいものはありますか？ 少しでも好きなものを」

入浴を嫌がるようになった利用者さん:

- 痛みで動くのがつらい？
- 裸になることへの抵抗？
- 体力が落ちて疲れる？
- → 「嫌がる」の背景を考えること = 緩和ケア的思考

スライド 10: グループワーク（5 分間）

** 「あなたが関わった利用者さん（患者さん）で、
もっとこうできたらよかったな、と思ったことは？」 **

- 正解はありません
- 批判しない、聞くことに集中
- 「自分だったらどうする？」を考えてみる
- 個人情報に配慮（名前は出さない）

1 人 1 分ずつ話して、残り 1 分で「共通点」を見つけてください。

☒ ガニエ第 6 事象：練習の機会を与える

スライド 11: グループワークの共有

ファシリテーターが 2-3 グループに発表を依頼

ポイント:

- 「気づいていた」のに「何もできなかった」経験が多い
- → それは「知識がなかった」のではなく「伝え方を知らなかった」だけ
- 今日からその「伝え方」を一つずつ学んでいきましょう

☒ ガニエ第 7 事象: フィードバックを与える

スライド 12: 困ったときの相談先

あなたが「何かおかしい」と感じたら:

Step 1: まず看護師に伝える

「〇〇さん、いつもと違って△△な様子です」

Step 2: 看護師が判断して医師に報告

→ 必要に応じて緩和ケアチームに相談

Step 3: カンファレンスで情報共有

あなたの「気づき」がチーム全体のケアを変える

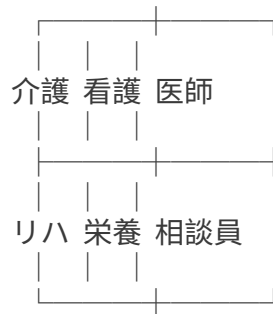
** 大切なのは「正確な医学的判断」ではなく、

「いつもと違う」と感じたことを伝えること。 **

連絡先	役割
---	---

スライド 13: 多職種で支えるということ

利用者さん・ご家族



事務・その他

全員の「気づき」が集まって、
はじめて「その人らしいケア」が実現する

** 介護職の「気づき」は、医師や看護師には見えないものを含んでいます。

スライド 14: まとめ

1. 緩和ケアは「終末期だけ」「がんだけ」のものではない
→ つらさを和らげること、すべてが緩和ケア
2. あなたの「いつもと違う」という気づきが出発点
→ 専門知識がなくても大丈夫。感じたことを伝えよう
3. 一人で抱えない。看護師に伝えることから始めよう
→ あなたの一言がチームのケアを変える

スライド 15: 小さな一歩から

今日のワーク：

明日から、利用者さんに一つだけ
いつもの声かけに「+ひと言」を加えてみてください。

例：「痛いところはありませんか？」

例：「何か気になることはありますか？」

例：「最近、眠れていますか？」

☒ ワークシート（配布）に書いてください：

- 「明日から試してみたい+ひと言」を1つ
- 1週間後に「やってみてどうだったか」を共有する時間を設けます

☒ ガニエ第8・9事象：学習の成果を評価する / 保持と転移を促進する

スライド 16: おわりに

目の前の人の「つらさ」に気づき、
寄り添い、伝える。
それは、皆さんが毎日していることの延長線上にあります。

ありがとうございました。

質問・感想があればいつでもお声がけください。

本スライドの出典：日本緩和医療学会全国調査 Palliative Care Research (J-STAGE), WHO 緩和ケアの定義 (2002 改訂)

作成：Learning Design Lab / AI Agent Team